

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

УДК: 616.6-08-035.75

Д.Р. Кайдарова, Г.Ж. Кунирова

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии
ОЮЛ «Казахстанская ассоциация паллиативной помощи»,
ОФ «Вместе против рака»

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ В КАЗАХСТАНЕ: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ТЕКУЩИЕ ВЫЗОВЫ

Аннотация. Статья посвящена анализу текущей ситуации и перспектив развития сравнительно нового направления здравоохранения – паллиативной помощи – в контексте помощи incurable онкологическим пациентам. Рассматриваются важные этапы развития службы в Казахстане, формы оказания помощи и имеющиеся ресурсы. Анализируются факторы, препятствующие развитию паллиативной помощи в РК и рассматриваются пути преодоления барьеров.

Ключевые слова: паллиативная помощь, incurable пациенты, доступность опиоидных анальгетиков, дефицит подготовленных кадров, мультидисциплинарные команды, мобильные бригады, хосписная помощь.

Введение. В Казахстане паллиативная помощь только начинает признаваться важной частью национальной системы здравоохранения. Рост онкологической заболеваемости (более 30 тыс. новых случаев в год, ежегодный прирост 3-5%), и высокий процент выявления заболеваний в распространенной форме (44,2%) указывают на необходимость разработки комплексной системы паллиативной помощи для неизлечимых пациентов с диагнозом рак [1]. Помимо 144 тыс. зарегистрированных онкологических пациентов, около 23 тыс. людей болеют туберкулезом, из которых около 8 тыс. страдают от мультирезистентных форм заболевания; 18 тыс. людей в Казахстане живут с ВИЧ [2]. От 35% до 67% пациентов с дыхательной, сердечной, печеночной недостаточностью, диабетом и множеством других хронических заболеваний нуждаются в паллиативных вмешательствах [3].

К сожалению, в Казахстане пока не существует специального регистра людей, которым требуется паллиативная помощь. В 2012 году Томас Линч, международный консультант по паллиативной помощи, провел анализ потребности в нашей стране и выявил, что в Казахстане, по самым скромным подсчетам, в паллиативной помощи нуждается от 94 200 до 97 900 пациентов в год, и, как минимум 15 500 пациентов в данный момент времени. Кроме того, поскольку, как правило, двое или более членов семьи непосредственно участвуют в процессе ухода за каждым пациентом, то количество бенефициаров от паллиативной помощи возрастает до 282 600 лиц ежегодно. Для того, чтобы должным образом обеспечить стационарную и амбулаторную паллиативную помощь,

т.е. как это рекомендует ВОЗ – всюду, где находится пациент, понадобится не только провести масштабное перераспределение городских и сельских специалистов, но и обучить и подготовить порядка 6 675 единиц персонала и организовать 825 паллиативных койко-мест [4].

Основные этапы развития паллиативной помощи в Казахстане

Первый хоспис был открыт в Алматы в 1999 году, и в течение трех последующих лет хосписы также были открыты в других пяти городах: Павлодаре, Караганде, Кустанае, Усть-Каменогорске и Семее. Однако законодательная основа для дальнейшего развития паллиативной помощи сформировалась только через 10 лет с включением паллиативной помощи в контекст национальной системы здравоохранения посредством принятия Кодекса о здоровье народа (2009 г.) и Государственной программы развития системы здравоохранения (2010 г.). Новая Национальная программа развития онкологии на 2012-2016 гг., разработанная в рамках данной Государственной программы, впервые предусматривала определенные индикаторы развития паллиативной помощи.

К 2012 году были приняты основные нормативно-правовые акты, устанавливающие категории пациентов, имеющих право на получение паллиативной помощи, категории медицинских и немедицинских работников, участвующих в процессе оказания паллиативной помощи, институты общественного здравоохранения и подразделения лечебно-профилактических учреждений, ответственные за организацию услуг, нормы материального обеспечения, формы медицинской документации и т.д.

За последние годы в развитии паллиативной помощи в Казахстане отмечается значительный прогресс, во многом, благодаря усилиям общественных организаций и энтузиастов. Первый отчет комплексной оценки потребностей, подготовленный Доктором Линчем в 2012 году, при поддержке Фондов Открытое общество, повлек за собой разработку документа по регулированию паллиативной помощи. Совместная работа казахстанских и международных специалистов, Фонда Сорос-Казахстан (ФСК), Республиканского центра по развитию здравоохранения (РЦРЗ), Высшей школы общественного здравоохранения (ВШОЗ), местных неправительственных организаций и адвокатов паллиативной помощи, способствовали тому, что в декабре 2013 года Министерство здравоохранения и социального развития утвердило Национальные стан-

дарты паллиативной помощи.

Важным моментом является то, что данный документ предусматривает в качестве поставщиков паллиативной помощи не только государственные учреждения здравоохранения, но и организации неправительственного сектора. Паллиативная помощь больше не рассматривается как чисто медицинская проблема, но официально признается социальная и психологическая составляющая этого вида помощи. Кроме того, теперь паллиативную помощь можно получать не только в хосписах, но и амбулаторно: в дневном стационаре и на дому при помощи мобильных мультидисциплинарных команд. Поддержка членов семьи при утрате близких включена в контекст паллиативной помощи. Стандарты также выделяют роль волонтеров и членов семьи в обеспечении полноценной паллиативной помощи, и обязывают поставщиков паллиативной помощи рассматривать образовательную, юридическую, социальную и психологическую поддержку, помимо контроля над симптомами и облегчения боли. Особое внимание уделяется педиатрической паллиативной помощи: психологические потребности смертельно больных детей упоминаются отдельно, а их семьи называются бенефициарами услуг паллиативной помощи [5].

Однако, самого по себе принятия Национальных стандартов паллиативной помощи недостаточно для того, чтобы стали происходить существенные изменения в клинической практике лечебно-профилактических учреждений. Необходима планомерная работа по изменению нормативно-правовой базы, внедрению образовательных программ и повышению осведомленности о преимуществах паллиативной помощи среди всего населения.

Такой деятельностью занимается Объединение юридических лиц «Казахстанская ассоциация паллиативной помощи» (КАПП), созданное в 2013 году по инициативе неправительственных организаций: ОФ «Вместе против рака» (Алматы), ОО «Кредо» (Караганда - Темиртау), ОО

«Адамгершилик» (Караганда), ОФ «Амазонки» (Тараз). В Ассоциацию могут входить не только НПО, но и государственные учреждения, поэтому одними их первых ряды членов ассоциации пополнили Алматинский онкологический центр и Алматинский центр паллиативной помощи. Расширяется и географический охват: в Ассоциацию вступили организации из Актобе, Усть-Каменогорска, Семей. Заключены меморандумы между КАПП и Лодзинской Ассоциацией хосписов, Российской Ассоциацией паллиативной медицины, Всеукраинской Лигой содействия развитию паллиативной и хосписной помощи, Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи.

На сегодняшний день КАПП играет лидирующую роль в продвижении идей и практики паллиативной помощи в Казахстане. Каждый из членов КАПП успешно реализуют проекты оказания паллиативной помощи в своих регионах, и кроме того занимаются образовательной и просветительской деятельностью. Благодаря этому вопросы развития паллиативной помощи все чаще включаются в повестку дня сессий Парламента, заседаний МЗСР РК, онкологических конференций и круглых столов в защиту прав пациентов.

Основные вызовы и перспективы дальнейшего развития

Основные проблемы в развитии паллиативной помощи в Казахстане включают: 1) ограниченный доступ к опиоидным анальгетикам и современным методам лечения боли, 2) дефицит обученных кадров и отсутствие системного обучения специалистов паллиативной помощи (включая немедицинские специальности), 3) недостаточное количество хосписов и паллиативных коек, низкий уровень развития амбулаторных услуг, недоступность паллиативной помощи в сельской местности, 4) низкий уровень общей информированности и недооценка экономических и клинических преимуществ паллиативной помощи.

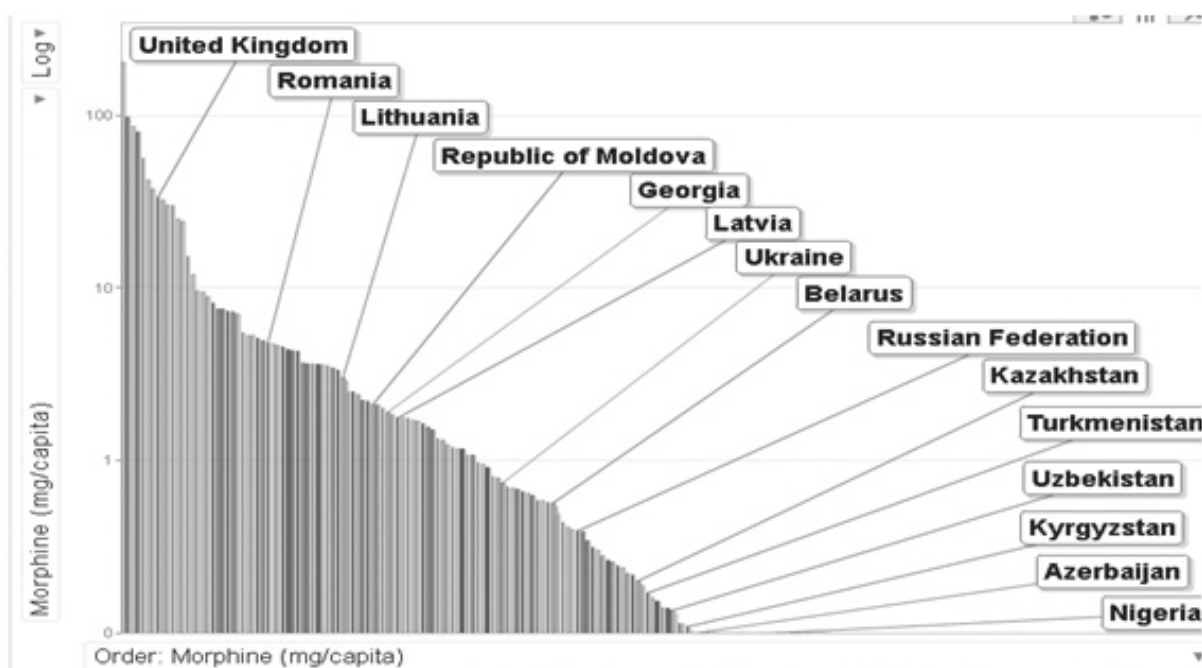


Рисунок 1 - Сравнительный график потребления опиоидов в медицинских целях в странах мира

Доступность опиоидов. В нашей стране существует много барьеров, ограничивающих доступность опиоидных анальгетиков и эффективного лечения боли. Казахстан входит в число стран с низким уровнем потребления опиоидов для медицинских и научных целей (рисунок 1). Общее количество опиоидов в пересчете на морфин составляет всего 0,1664 мг.на душу населения, что оставляет нашу страну на 130-м месте в мире (таблица 1). Данная проблема происходит из применения устаревшего метода оценки спроса на наркотические анальгетики, осно-

ванного на потреблении прошлых лет. Расчет страновой потребности, согласно рекомендации ВОЗ, должен основываться на: стандартной дневной дозе, расчете на количество населения, количестве коек. Данный вопрос продолжает подниматься на уровне МЗСР, однако несогласованность в действиях различных отделов данного ведомства препятствует эффективному диалогу по этому вопросу. Таким образом, не создается предпосылка для увеличения страновой квоты на опиоиды в Международном комитете по контролю над наркотиками (INCB) [6].

Таблица 1 - Суммарное потребление опиоидов в Казахстане

Вид опиоидов	мг на душу населения	эквивалент морфия (мг на душу населения)
Фентанил	0,0110	0,9185
Гидроморфон	--	--
Метадон	--	--
Морфий	0,2479	0,2479
Оксикодон	--	--
Петидин	--	--
ИТОГО в морфиновом эквиваленте:		0,1664

Перечень опиоидных анальгетиков в Национальном лекарственном формуляре изменился лишь незначительно в последние три года. Список доступных препаратов в основном включает внутривенные формы, что нарушает первый рекомендованный ВОЗ принцип обе-

зболивания – через рот. Количество ввозимого в страну фентанилового пластыря ничтожно мало, что является следствием низкой квоты РК на фентанил. Пероральные формы морфина все еще недоступны в Казахстане (таблица 2, 3) [7].

Таблица 2 - Перечень опиоидов, используемых для премедикации и в послеоперационный период

1.3.	Предоперационные лекарственные средства и седативные средства для проведения непродолжительных процедур	
14	Атропин	раствор для инъекций 1 мг/мл
15	Диазепам	раствор для инъекций 10 мг/2 мл; таблетки, таблетки покрытые оболочкой, 5 мг
16	Морфин	раствор для инъекций 1 %
17	Прометазин	раствор для инъекций 50 мг/2 мл; драже 25 мг
18	Фентанил	раствор для инъекций 0,005 %; система терапевтическая трансдермальная 12,5 мкг/час; 25 мкг/час, 50 мкг/час; 75 мкг/час и 100 мкг/час; таблетки сублингвальные 100мг, 200мг, 300мг, 400мг, 600мг, 800мг
19	Тримеперидин	раствор для инъекций 1 %, 2 %

Таблица 3 - Опиоидные анальгетики, входящие в национальный лекарственный формуляр

2.2.	Опиоидные анальгетики	
31	Морфин	раствор для инъекций 1 %
32	Тримеперидин	раствор для инъекций 1 %, 2 %
33	Трамадол	раствор для инъекций 100 мг/2мл, 50 мг/мл, 5 %; раствор для приема внутрь 100 мг/1 мл; капли 1000мг/10мл; таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг; таблетки ретард (покрытые пленочной оболочкой) 100 мг, 150 мг, 200 мг; капсулы 50 мг; суппозитории ректальные 100 мг
34	Фентанил	раствор для инъекций 0,005 %; система терапевтическая трансдермальная 12,5 мкг/час, 25 мкг/час, 50 мкг/час, 75 мкг/час, 100 мкг/час; таблетки сублингвальные 100мг, 200мг, 300мг, 400мг, 600мг, 800мг
35	Бупрофанол	раствор для инъекций 2 мг/мл
19	Тримеперидин	раствор для инъекций 1 %, 2 %

В странах Запада на сегодня зарегистрировано 23 молекулы сильнодействующих опиоидов и применяется до 60 неинвазивных форм опиоидов. Казахстан должен значительно расширить перечень препаратов в таких документах как «Правила использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан» (Приказ №32), «Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами» (Приказ №786) и ряде других документов, включив в них не только таблетированные формы опиоидов короткого и пролонгированного действия, но и другие контролируемые препараты с доказанной эффективностью в терапии хронической боли – антидепрессанты, противосудорожные препараты и пр.

В то время как средняя доза морфина в развивающихся странах и странах с низким уровнем дохода составляет 60-75 мг в день, средняя дневная доза в Казахстане не превышает 30-40 мг. Данная проблема отражает недостаток знаний о приеме опиоидных препаратов и облегчении боли среди практикующих врачей. Боязнь опиоидных препаратов является распространенным явлением среди врачей, которые зачастую игнорируют различие между зависимостью и переносимостью, и склонны назначать неадекватно низкие дозы, неэффективные в облегчении боли.

Другим ограничением является то, что в Казахстане действуют слишком строгие процедуры лицензирования, транспортировки, хранения, предписания, выдачи и утилизации опиоидных анальгетиков. В результате лишь малое число аптек стремится получить лицензию и осуществлять отпуск наркосодержащих препаратов из-за

многочисленных проверок со стороны контролирующих органов.

В 2015 году в Приказ №32 внесены некоторые изменения, например, отменено требование сдачи пациентами пустых ампул и упаковок для выписки новой дозы препарата; увеличен срок действия рецепта до 15 дней, и т.д. В настоящее время МЗСР готовит новую редакцию Приказа №32, в который должны войти изменения, в том числе предложенные КАПП, которые направлены на дальнейшее сокращение маршрута пациента и устранение барьеров [8].

Вопросу доступа к обезболиванию в Казахстане были посвящены Круглый стол «Доступность препаратов для лечения боли: пути решения проблемы», прошедший 4 декабря 2012 г. в г. Алматы, а также Круглый стол «Доступные опиоиды – право каждого», прошедший в Астане 23 октября 2015 года. К обсуждениям, организованным КАПП были привлечены авторитетные международные эксперты, представители Министерства здравоохранения и социального развития, Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел, члены Парламента, врачи-онкологи, представители хосписов, общественных организаций, фармацевтических компаний. В продолжение обсуждений 22-23 сентября 2016 года в г. Астана пройдет Круглый стол по доступности опиоидов и Тренинг по противоболевой терапии под общим названием «Остановите мою боль!».

Проблема нехватки кадров и системного обучения. Еще одна большая проблема – низкий уровень знаний о паллиативной помощи как в обществе, так и среди медицинских работников.

В Казахстане был запущен ряд великолепных инициатив по обучению основам паллиативной помощи, при поддержке международных и местных организаций. От 150 до 200 энтузиастов паллиативной помощи, включая

врачей, медсестер, психологов, социальных рабочих и лидеров НПО, участвовали в курсах ELNEC, семинарах в Зальцбурге, курсах Европейской школы боли и других всемирно известных программах обучения. По крайней мере три мультидисциплинарные команды из Караганды, Алматы и Тараза при финансовой поддержке Фонда Сорос-Казахстан (ФСК) посетили зарубежные хосписы и ознакомились с работой отделений паллиативной помощи и выездных служб.

Предоставленные ФСК гранты и сотрудничество с такими международными организациями как Евразийское общество онкологов (EAFO), Американское общество клинических онкологов (ASCO), Национальный институт рака США (NCI), Ближневосточный противораковый консорциум (MECC) дали возможность организациям, входящим в КАПП провести в Казахстане за последние несколько лет несколько конференций и семинаров, включая:

- Международную научно-практическую конференцию «Проблемы в развитии паллиативной помощи в Республике Казахстан» (7-8 декабря 2011 г., г. Караганда),
- Международный форум по паллиативной помощи в рамках Съезда онкологов стран СНГ (7 сентября 2012 г., Астана),
- Международную научно-практическую конференцию «Поддерживающая терапия и паллиативная помощь в онкологии» (5 декабря 2012 г., Алматы),
- Международную научно-практическую конференцию «Современные аспекты паллиативной помощи и сестринского ухода» (28-29 июня 2013 г., г. Караганда),
- Евразийский противораковый форум «Предикция, превенция и паллиативная помощь в онкологии» (10-11 октября 2013 г., Алматы),
- Мастер-класс для онкологов «Принципы оказания паллиативной помощи и лечения онкологических больных» (9-14 июня 2014 г., Алматы),
- Семинар-тренинг для медсестер «Новые технологии оказания паллиативной помощи» (20-24 июля 2015 г., Алматы),
- Международная конференция «Паллиативная помощь: новое качество жизни» (22 октября 2015 г., Астана),
- Международный семинар IPCW 2016 с участием лекторов ASCO (11-13 мая 2016 г., Алматы).

Последний названный семинар, собравший 173 специалиста со всего Казахстана, выявил значительно возросший интерес к практическим вопросам оказания психологической, социальной, духовной помощи пациентам и их семьям, вопросам оценки и купирования боли и других симптомов, развитию коммуникативных навыков, методам психологической самопомощи и т.д. Еще два крупных проекта при поддержке Национального института рака и Казахского НИИ онкологии и радиологии планируется провести в 2016-2017 гг.

С 2011 года Карагандинский государственный медицинский университет ввел факультативный курс для медицинских студентов 4 курса и интернов. Данный курс обучения был разработан при поддержке польских коллег, и также может быть введен в других высших образовательных учреждениях или предложен Министерству образования и науки Республики Казахстан.

Проекты паллиативной помощи в Казахском Национальном университете им. С.Д. Асфендиярова сосредоточены на геронтологических пациентах и включают разработку организационно-функциональной модели помощи на дому и больничной помощи таким пациентам, а также разработку клинических протоколов для паллиативной помощи.

Краткосрочные курсы обучения организованы на нерегулярной основе такими образовательными учреждениями, как Казахская высшая школа общественного здравоохранения и Казахский медицинский институт непрерывного образования.

Информационные кампании и семинары продолжают регулярно проводиться организациями-членами КАПП во всех регионах Казахстана.

Министерством здравоохранения и социальной защиты ежегодно проводится конкурс на государственную закупку услуг по совершенствованию услуг паллиативной помощи и сестринского ухода в целях обучения лиц, нуждающихся в этих видах услуг и их родственников.

Однако всех этих образовательных усилий явно недостаточно для обеспечения растущей потребности в специалистах паллиативной помощи по всему Казахстану.

Проблема обучения специалистов должна быть признана на правительственном уровне. Национальный классификатор профессий должен включать такую специальность как «паллиативная помощь» или «паллиативная медицина». Отсутствие законодательной базы на включение паллиативной помощи в национальные стандарты образования препятствует внедрению программ обучения в практические занятия медицинских образовательных учреждений.

Необходимо разработать и внедрить методологическую базу, стандарты преподавания и оценочный процесс для обучения медицинских (врачи, медсестры) и немедицинских (социальные рабочие, психологи) специалистов по паллиативной помощи по трем уровням:

- Базовый (додипломный) уровень – для тех, кто будет иметь профессиональное отношение к медицине
- Средний (последипломный) – для профессиональных докторов, которые в своей практике столкнутся с вопросами паллиативной помощи, не являясь специалистами в данной области; и
- Продвинутый – для тех, кто захочет стать специалистом паллиативной помощи.

В организации обучения персонала паллиативной помощи может оказаться полезным богатый опыт работы неправительственного сектора и их интернет-ресурсы (например, сайт Казахской ассоциации паллиативной помощи www.palliative.kz, где в открытом доступе имеется русскоязычная библиотека с материалами для обучения и видео-семинарами) [9].

Также целесообразно было бы организовать на базе хосписов центры по обучению врачей, медсестер, психологов и социальных работников практическим основам паллиативной помощи, а также обучение санитаров, волонтеров и членов семей практическим навыкам ухода и психологической помощи.

Доступ к паллиативной помощи в условиях стационара, поликлиники, амбулатории и на дому



Вид помощи	2001 г.	2011 г.	2016 г.
Стационарные койки	200+	400+	800+
Регулярные мобильные бригады	0	3	6
Противоболевые кабинеты	0	2	10+



Рисунок 2 - Карта доступности различных форм паллиативной помощи в регионах Казахстана (по данным, собранным КАПП)

План развития онкологической помощи на 2012-2016 гг. предусматривал создание паллиативных коек в городах Астана, Петропавловск, Актобе и Кызылорда в 2013 году, а также открытие отделений паллиативной помощи в онкодиспансерах Талдыкоргана, Алматы, Уральска, Атырау, Шымкента и Тараза за период с 2014 по 2016 годы. На сегодняшний день, около 150 новых паллиативных коек были развернуты в рамках данного плана, в том числе открыты отделения терапии и паллиативной помощи для онкологических пациентов г. Астаны, Кызыл-Орды, Шымкента [10].

Таким образом, на сегодняшний день в Казахстане имеется 13 учреждений, где предоставляют стационарное лечение, включая хосписы, центры сестринского ухода и отделения симптоматического лечения и паллиативной помощи. Общее число койко-мест, согласно информации МЗСР РК, составляет более 800, однако и этого количества недостаточно для населения более 17 миллионов человек. Простая логика подсказывает, что в каждом городе страны должен быть свой хоспис, мощностью от 8 до 30 коек.

К сожалению, паллиативная помощь практически недоступна для пациентов, живущих в отдаленных районах. В сельских районах и маленьких городах целесообразно

развивать амбулаторные формы паллиативной помощи и помощь на дому.

Пациенты, страдающие от распространенных форм рака, выписанные из онкологических центров или больниц, попадают в компетенцию муниципальных амбулаторных клиник. Уход за ними переходит в зону ответственности врачей общей практики и штатных онкологов, которые не имеют необходимых навыков оказания паллиативной помощи для решения медицинских, психологических, социальных и духовных проблем таких пациентов. Как правило, они не располагают необходимыми ресурсами (транспорт, поддержка многопрофильной бригады, квалифицированные медсестры, психолог, социальный рабочий, волонтеры, специальные средства для ухода, расходные материалы, препараты и т.д.).

Четыре НПО: «Кредо» в Караганде и Темиртау, «Амазонка» в Таразе, «Вместе против рака» в Алматы и «Солярис» в Павлодаре, провели обучение для мультидисциплинарных команд и запустили проекты мобильной помощи для неизлечимых пациентов на дому. В Караганде и Темиртау МДК работали 4 года за счет гранта ФСК, один год за счет областного управления здравоохранения. В течение года проводились консультации специалистов по телефону для онкологических пациентов при

финансировании управления здравоохранения. В Алматы проект МДК финансировался в течение года ФСК, а с 2016 года мобильная бригада вошла в штат Алматинского онкологического центра. Таким образом, в Алматы удалось добиться устойчивости проекта, востребованность которого подтверждается ежедневно. Кроме того, Алматинский центр паллиативной помощи запустил свою собственную мобильную бригаду.

Развитие мобильных команд способствует необходимой преемственности между медицинскими учреждениями различных уровней, которые разделены административно. Наличие такой сети открывает больше возможностей для пациентов к получению доступа к консультациям специалистов узкого профиля, к диагностическим и лабораторным услугам, к малоинвазивным операциям и помощи психологов и социальных работников.

Заключение. Несмотря на имеющиеся положительные сдвиги в развитии паллиативной помощи в Респу-

блике Казахстан, имеется еще целый ряд проблем, требующих скорого решения.

Главным залогом улучшения качества жизни инкурабельных пациентов в Республике Казахстан является: 1) воля государства в развитии паллиативной помощи на основе лучшей мировой практики, 2) обеспечение доступности опиоидных анальгетиков, 3) создание многоуровневой системы обучения медицинских и немедицинских специалистов.

Казахстанская ассоциация паллиативной помощи была учреждена с целью объединения усилий всех структур казахстанского общества: Парламента, министерств и ведомств, медицинского сообщества, неправительственного сектора, фармацевтических компаний, образовательных учреждений, а также международных экспертов и партнерские организации с целью ускорения процесса развития паллиативной помощи в Казахстане.

Список литературы

- 1 Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2014 год. – Алматы, 2015.
- 2 Официальный сайт МЗСР РК. www.mzsр.gov.kz
- 3 Паллиативная медицинская помощь //информационный бюллетень №402, ВОЗиюль 2015 г.
- 4 Оценка потребности в паллиативной помощи в Республике Казахстан, Томас Джеймс Линч, Программа общественного здравоохранения Фонда «Открытое общество», Международная инициатива по паллиативной помощи (IPCI), октябрь 2012 г.
- 5 Казахстан: утвержденные Национальные стандарты паллиативной помощи, Айнура Шакенова, Координатор программы правовой реформы и координатор развития паллиативной помощи, Фонд Сорос-Казахстан, 28 февраля 2014 г. www.ehospice.com
- 6 Интерактивная карта потребления опиоидов в медицинских и научных целях в странах мира. <https://ppsg.medicine.wisc.edu/chart>
- 7 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан, 9 сентября 2011г. №593 Об утверждении Республиканского лекарственного формуляра (с дополнениями и поправками от 12 апреля 2013 года).
- 8 О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 января 2015 года № 32 «Об утверждении Правил использования в медицинских целях наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан»
- 9 Сайт Казахстанской Ассоциации паллиативной помощи www.palliative.kz
- 10 Национальная программа развития онкологии на 2012-2016 гг.

Тұжырым

Д.Р. Қайдарова, Г.Ж. Коңырова
Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институты
ОЮЛ «Казахстанская ассоциация паллиативной помощи», ОФ «Вместе против рака»

**ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПАЛЛИАТИВТІК КӨМЕК:
ДАМУ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН АҒЫМДАҒЫ
СЫН-ТЕГЕУРІНДЕР**

Мақала ағымдағы жағдайды және денсаулық сақтаудың салыстырмалы түрде жаңа бағытының – паллиативтік көмек-контекстінде онкологиялық науқастарға инкурабельдік көмектің даму перспективасын талдауға арналған. Қазақстандағы қызметті дамытудың маңызды кезеңдері, көмек көрсету формалары мен қолда бар ресурстар қарастырылады. ҚР паллиативтік көмекке кедергі болатын факторлар талданып, кедергілерді жеңу жолдары қарастырылады.

Түйінді сөздер: паллиативтік көмек, жазылмайтын науқастар, опиоидты анальгетиктерге қол-жетімділігі, дайындалған кадрлардың жетіспеушілігі, мультидисциплинарды команда, мобильді бригада, хоспистік көмек.

Summary

D.R. Kaidarova, G.Zh. Kunirova
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии
ОЮЛ «Казахстанская ассоциация паллиативной помощи», ОФ «Вместе против рака»

**PALLIATIVE CARE IN KAZAKHSTAN:
MAIN MILESTONES AND CURRENT CHALLENGES**

This article is analyzing the current situation and prospects of development of a comparatively new branch of public healthcare – palliative care – in the context of social-medical assistance to incurable cancer patients. Main milestones of the Kazakhstan palliative care development are being considered, as well as possible forms of care and available resources. The article also analyzes main factors preventing from introduction of efficient palliative care practices and suggests possible ways of eliminating the barriers.

Key words: palliative care, incurable patients, availability of opioid analgesics, deficit of trained personnel, multidisciplinary teams, mobile teams, hospice care.